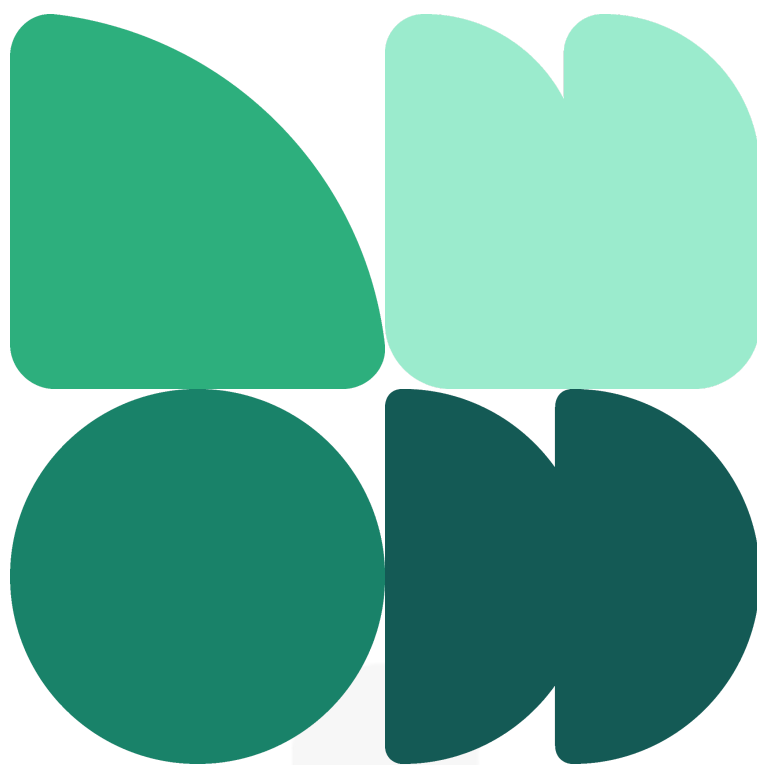


Resultados **MENSAGERIA** **PARA O** **CIDADÃO**



RESULTADOS

3.1 Envio das mensagens

Na avaliação randomizada da iniciativa de envio de mensagens ao cidadão, observou-se um número significativo de telefones viáveis entre as fichas de cadastro. Aproximadamente **24% dos cadastros continham números de telefone**. Entre esse total:

- A taxa de erro no envio (números inválidos ou não cadastrados no WhatsApp) foi de 2,6% (145 em 5.574 números) para todos os grupos com envios de mensagem (braços “A” e “B”, para as condições de crônicos e citopatológico).
- Outros 3,6% (198 em 5.574) dos integrantes deste grupo responderam as mensagens enviadas com a opção “Não sou eu”.

Para a condição do citopatológico, a taxa de agendamento de exames no braço da intervenção em que essa funcionalidade era oferecida (grupo “A”) foi de 5,2% (80 de 1.514). Esse resultado foi semelhante ao observado no mesmo grupo da intervenção para doenças crônicas - 5,4% (69 de 1.273) dos números que receberam mensagens utilizaram a função de agendamento para marcar uma consulta.

3.1.1 Efetividade em relação a realização dos exames

Quanto à efetiva realização dos exames citopatológicos, a proporção verificada após 45 dias dos envios (ou o dia de referência, no caso do grupo controle) foi de 2,6% (40 de 1.514) nos braços do lembrete *com* agendamento (grupo “A”); de 3,1% (47 de 1.514) no braço do lembrete *sem* agendamento (grupo “B”); e de 1,3% no controle (grupo “C”). Para o público com doenças crônicas, as proporções de pessoas que tiveram atendimentos registrados em suas respectivas unidades de saúde em até 45 dias após a intervenção foram de 20,7% (263 de 1.273) para os braços dos lembretes com agendamento (grupos “A”); 21% (267 de 1.273) no braço do lembrete *sem* agendamento e de 20,7% (264 de 1.274) no controle (grupo “C”).

Em termos de tamanho do efeito da intervenção, esses resultados sugerem um efeito estatisticamente significativo para a intervenção com foco no exame citopatológico. A comparação com o grupo controle do grupo **com agendamento** sugere um aumento ao redor de +110% na probabilidade de um indivíduo realizar o exame

citopatológico ao receber um lembrete com opção de agendamento do que sem nenhum lembrete, sendo estatisticamente possível afirmar que, com 95% de certeza, o efeito real sobre o aumento da probabilidade está entre +22% e +261%. Para o lembrete **sem agendamento, o efeito adicional sobre a probabilidade de realizar o exame está ao redor de +147%**, com 95% de confiança de que o valor real está entre +46% e +319%.

Já para a intervenção com foco **em doenças crônicas, os resultados não sugerem uma diferença estatisticamente significativa**. Para o grupo dos lembretes *com* agendamento, o efeito sobre a probabilidade de realizar uma consulta no período considerado foi de -0,3% em relação ao controle, sendo possível afirmar com 95% de confiança de que a diferença real sobre a probabilidade de realizar uma consulta está entre -14% e +16%. Para o grupo dos lembretes *sem* agendamento, o efeito foi de +1%, com 95% de confiança de que o valor real se encontra entre -13% e +18%.

3.2 Entrevistas com coordenadores de equipe

A etapa de entrevistas de avaliação do projeto piloto foi realizada com o objetivo de coletar dados detalhados sobre a percepção das coordenações de equipe da iniciativa de envio de mensagens para a população. As entrevistas foram realizadas presencialmente em três municípios, Juquitiba (SP), Inhambupe (BA) e Palmeira das Missões (RS), e de forma online em Viana (MA).

Ao todo, foram realizadas 18 entrevistas com coordenadoras de equipe, superando nossa expectativa de entrevistar 15 coordenadores, distribuídas conforme o quadro abaixo:

Município parceiro	Tipo de entrevista	Nº de entrevistas realizadas
Juquitiba	Presencial	5
Inhambupe	Presencial	5

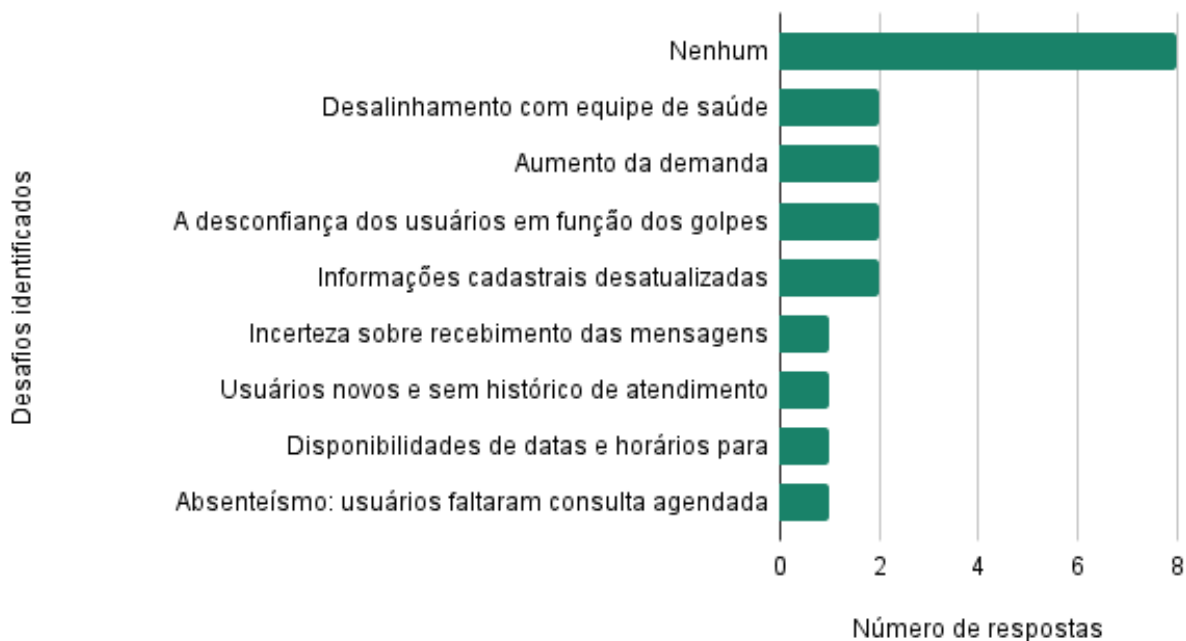
Palmeira das Missões	Presencial	6
Viana	Online	2
Total		18

3.2.1 Percepções gerais da iniciativa

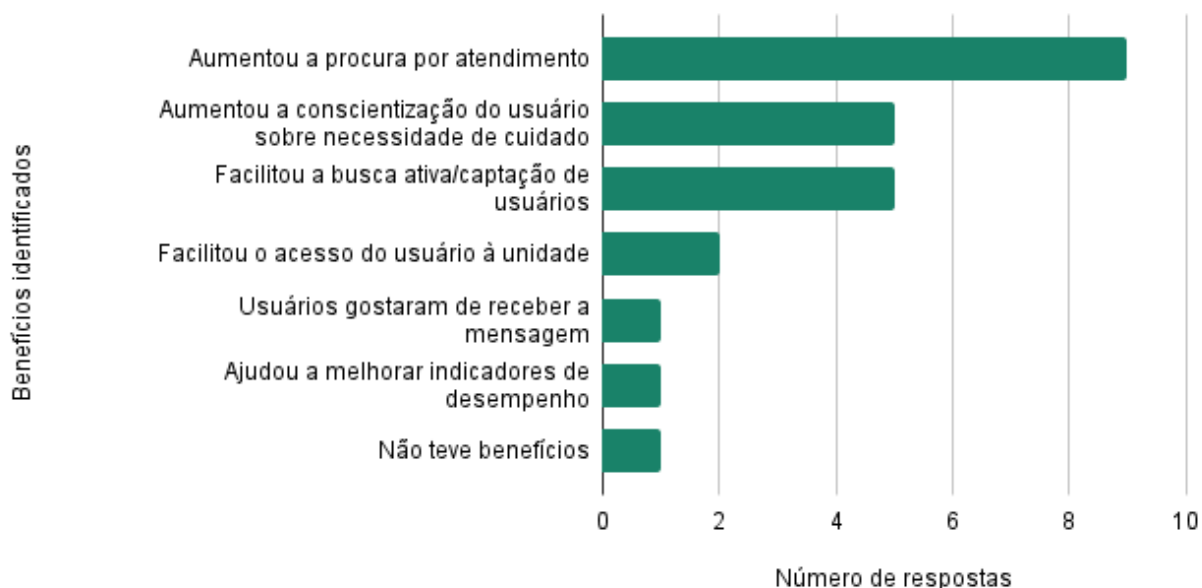
O grau de satisfação com a iniciativa de Mensageria foi em média 4,6, considerando a escala de 1 a 5, sendo 1 “muito insatisfeito” e 5 “muito satisfeito”. Além disso, 100% das coordenadoras entrevistadas responderam que participariam novamente da iniciativa.

De todas as entrevistadas, 94% relatou que a iniciativa de mensageria trouxe benefícios ao seu trabalho, sendo os benefícios mais citados o aumento na procura por atendimento, o aumento da conscientização dos usuários sobre a necessidade de cuidado e o auxílio na busca ativa e captação de usuários.

Desafios identificados com a iniciativa



Benefícios identificados com a iniciativa



Ao abordarmos os desafios enfrentados pelas coordenadoras, 44% delas relatou que não houveram desafios durante a iniciativa. Das 66% que enfrentaram desafios com a iniciativa, os seguintes foram citados:

- Desalinhamento com equipe de saúde: houve o relato de que membros da equipe não estavam completamente a par do andamento da iniciativa e isso demandou da coordenação de equipe
- Aumenta da demanda: por menor que seja o número de atendimentos a mais a serem realizados, se estes forem demandados em momentos pouco oportunos, podem gerar bastante incômodo para a equipe assistencial
- A desconfiança dos usuários: foram muitos os relatos de que esta foi a primeira impressão de muitos usuários ao receberem a mensagem
- Informações cadastrais desatualizadas: muitos usuários possuem em seus cadastros individuais números de telefone de outras pessoas/instituições registrados como o telefone de seu ACS, da unidade de saúde, da secretaria de saúde ou de um serviço hospitalar.
- Incerteza sobre o recebimento das mensagens: as coordenadoras relataram que a falta de visibilidade de quem do território recebeu uma mensagem da Impulso foi um desafio

- Usuários novos e sem histórico de atendimento: como a iniciativa conseguiu trazer à unidade usuários que nunca tinham recebido atendimento antes, usuários não possuíam informações de saúde em seus prontuários, o que se demonstrou um desafio para as coordenadores
- Disponibilidades de datas e horários: por mais que as disponibilidades ofertadas fossem informadas pelas próprias coordenadoras, percebemos que houveram desalinhamentos entre o turno sugerido e o melhor momento para atendimento conforme o fluxo da unidade
- Absenteísmo: usuários que agendaram atendimento pelo WhatsApp acabaram faltando a consulta

No município de Juitiba, a disponibilidade de horários para agendamento pareceu ser o principal desafio enfrentado, enquanto em Inhambupe, foram as informações desatualizadas nas bases cadastrais.

Ao serem questionadas quais são os receios atuais em relação a Mensageria hoje, 66,7% respondeu que não possuem receios com a continuidade da iniciativa. Os receios que foram relatados pelos outros 33,3% das coordenadoras foram os seguintes:

- Aumento excessivo de demanda por atendimento
- Necessidade de ajuste das disponibilidades oferecidas para agendamento
- Medo da população desqualificar a unidade por erros com disponibilidades de agendamentos
- Receio das mensagens não atingirem/impactarem público idoso
- Receio da falta de continuidade da iniciativa

3.2.2 Sugestões de melhorias

Abaixo estão as sugestões de melhorias citadas pelas coordenadoras de equipe, indicando quais foram citadas mais de uma vez:

- *Continuidade da iniciativa*
 - Continuidade dos disparos iniciados com público de citopatológico e condições crônicas (4 citações)

- Continuidade de trabalho em campo, para melhor compreender as dificuldades enfrentadas nos municípios
- *Público-alvo das mensagens*
 - Ampliar o número de pessoas que recebem mensagens, visto que há capacidade do serviço de saúde realizar mais atendimentos (2 citações)
 - Realizar disparo de mensagens focado na busca ativa para atualização vacinal de crianças (5 citações)
 - Sobretudo com crianças menores de um ano
 - Realizar disparo de mensagens focado na busca ativa de gestantes (5 citações)
 - Realizar disparo de mensagens focado na busca ativa de beneficiários do Bolsa Família
 - Realizar disparo de mensagens sobre dengue para conscientização da população
 - Continuar focando no público que está em atraso com algum atendimento, pois é o prioritário de busca ativa
 - Continuar disparos testando a aceitação de outros públicos
- *Conteúdo das mensagens*
 - Mensagem pode assumir tom ainda mais impactante, mais sério e alarmante, para responsabilizar e intimidar a população a buscar atendimento (2 citações)
 - Incluir nas mensagens informações sobre o atendimento realizado pela equipe de enfermagem, pois para o público de condições crônicas, sem essa especificação, cria-se a expectativa de atendimento realizado por médica/o
 - Utilizar áudio e/ou mensagens SMS para público de condições crônicas, pois muitos são idosos que não possuem smartphone, logo não têm WhatsApp ou não sabem usar
- *Ajustes operacionais da iniciativa*

- Ampliar e qualificar visibilidade das equipes de quais pessoas receberam mensagens, quais mensagens, e se houve algum retorno/agendamento realizado por elas (3 citações)
- Possibilitar que a própria unidade de saúde indique quais são os usuários que irão receber mensagens
- Alinhar envio de mensagens com maior antecedência para melhor preparo da equipe em receber usuários
- Ampliar a frequência de envio de mensagens, sugestão de um envio por mês
- Ampliar comunicação no território sobre a realização da iniciativa
- Enviar lembrete do agendamento realizado (isso já ocorreu no piloto mas a equipe teve pouca visibilidade)
- Atrelar disparo de mensagem com dia de atendimento coletivo/grupo para pessoas com condições crônicas, quando há também realização de atendimento médico

Processo de implementação da iniciativa: impressões iniciais, reunião de apresentação e comunicação com a equipe de saúde

3.2.3 Primeiras impressões

Quando questionadas qual foi a primeira impressão acerca do projeto de Mensageria, 72% das coordenadores relataram percepções muito positivas. Destaca-se o caráter inovador da iniciativa e o potencial de facilitar a comunicação no território, trazendo uma outra forma de aproximar a equipe de saúde com população assistida, chamando a atenção para o autocuidado.

As demais coordenadoras de equipe, representando 28% da amostra, tiveram as primeiras impressões mistas ou negativas. As coordenações acharam que não daria certo por um possível baixo engajamento da população e pelo público ser leigo/com dificuldade de compreensão. Também houve a percepção de que a iniciativa fosse funcionar melhor para o público-alvo de citopatológico do que de condições crônicas,

por conta deste segundo grupo ser de maioria idosa, com menos acesso e aderência ao WhatsApp.

Ao serem questionadas especificamente sobre receios gerados no primeiro contato com a iniciativa, 28% das entrevistadas relataram que não tiveram receios, enquanto 72% tiveram. Dentre as 12 entrevistadas que expressaram receios, a maior parte expressou receios envolvendo os usuários, sendo 33,3% quanto à possível desconfiança dos usuários em relação às mensagens recebidas, temendo que a falta de familiaridade com a iniciativa gerasse a interpretação de ser um golpe, e outros 33,3% temendo que os usuários não engajassem nas mensagens. Além disso, também foi citado o receio de gerar uma sobrecarga de demanda para o serviço (16,7%) e de erros cadastrais inviabilizarem a iniciativa (16,7%).

3.2.4 Reunião de apresentação e comunicação com equipe

Em relação a reunião de apresentação realizada com as coordenações de equipe, é importante mencionar que os cenários destas reuniões foram muito diferentes entre municípios, alguns sendo presenciais, outros online, sendo realizada 1 ou 2 reuniões. De forma geral, não parece ter tido problemas graves de compreensão das etapas da iniciativa, sendo que 77,8% afirmaram que a reunião foi o suficiente para entenderem o projeto e 22,2% parcialmente suficiente. Ao serem questionadas o que poderia ter sido melhorado, percebemos que os motivos citados não foram relativos à reunião mas sim ao contexto municipal ou a outras etapas da iniciativa.

A grande maioria (83,3%) das coordenadoras de equipe relataram que tiveram tempo suficiente para comunicarem suas equipes sobre esta iniciativa antes do início do envio das mensagens, que ocorreu poucas semanas depois da reunião de apresentação. Os ACS foram os principais profissionais a serem avisados sobre a iniciativa e percebemos que pode ter ocorrido falha na comunicação com outros profissionais que atuam na recepção e acolhimento das unidades (como recepcionistas e técnicas de enfermagem). Notamos que muitas coordenações de equipe avisaram suas equipes sobre a iniciativa de Mensageria através de grupos de trabalho no WhatsApp.

3.2.5 Mensagens enviadas à população

Em relação ao conteúdo das mensagens enviadas, 44,4% das entrevistadas achou este adequado à população de seu território, 50% achou parcialmente adequado e apenas 5,6% achou inadequado.

As coordenadoras relataram, em diferentes municípios, que é essencial utilizar o termo "exame preventivo" ao se referir à coleta do citopatológico. Elas destacaram que as mensagens não poderiam ser mais longas do que foram, pois se fossem maiores, os usuários poderiam não lê-las. Notaram também que a mensagem parecia mais adequada para o público-alvo de citopatológico do que para aqueles com condições crônicas.

Além disso, relataram uma falta de comunicação inicial sobre o conteúdo das mensagens, o que dificultou a explicação para a população. É essencial que as equipes estejam cientes da mensagem antes do envio.

Em Juquitiba, foi observado que as sugestões de qualificação das mensagens refletiam uma preferência das coordenadoras pelas mensagens do tipo A, em vez das mensagens do tipo B.

Para que a mensagem ficasse mais qualificada, as coordenações sugeriram algumas adequações:

- Adicionar informações da unidade de saúde: adicionar o nome da unidade de referência e o telefone de contato
- Adicionar áudio em conjunto com a mensagem, sobretudo para usuários com condições crônicas, por muitos serem idosos com dificuldade de usar tecnologia ou por analfabetismo da população
- Orientar “Compareça à sua unidade de saúde caso você não tenha esta condição de saúde”, devido ao alto número de usuários com identificação errada de condição crônica em prontuário
- Orientar “Compareça à sua unidade de saúde caso você tenha realização da coleta do citopatológico em serviço/clínica privada”
- Destacar a confidencialidade do atendimento para coleta de citopatológico, devido a vergonha e/ou receio da comunidade em realizar procedimento na unidade.

- Adicionar informação sobre o rastreio do câncer de mama junto à mensagem de citopatológico
- Adicionar “opções” na mensagem, como botão para voltar e mais detalhamento sobre disponibilidades para atendimento

3.2.6 Mensagens enviadas à população: tipo A e tipo B

Aprofundando os tipos de mensagens enviadas, sendo a “tipo A” aquela COM disponibilidades de horários para agendamento e a mensagem “tipo B” aquela SEM horários disponibilizados para agendamento, apenas com incentivo à procurar a unidade de saúde.

A maior parte das coordenadoras (81,25%) acharam que as disponibilidades oferecidas na mensagem “tipo A” estavam adequadas ao fluxo de atendimento da unidade, duas coordenadoras (12,5%) acharam parcialmente adequada e uma (6,25%) achou inadequada.

No que se refere às mensagens do “tipo B”, 77,8% das entrevistadas relataram que pessoas que receberam desse tipo buscaram a unidade para atendimento, enquanto 16,6% relataram que não houve procura deste público e 5,6% não soube confirmar.

Naquelas unidades em que a mensagem “tipo B” acarretou em procura pelo serviço de saúde, 38,5% das coordenadoras relataram que realizaram agendamento de consulta para os usuários, 30,7% relatou que realizaram o atendimento por demanda espontânea no mesmo momento, 15,4% priorizou o atendimento por demanda espontânea mas precisou também agendar consulta em algumas situações e 15,4% orientaram o dia correto para buscar a unidade para atendimento.

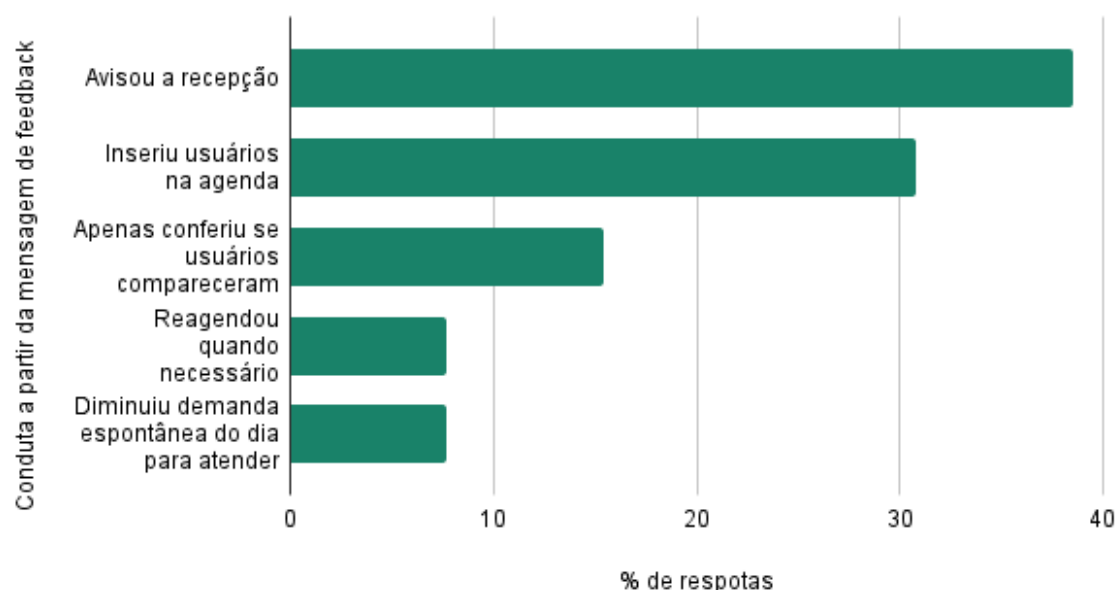
3.2.7 Mensagens de feedback enviadas às coordenações de equipe

Em relação à mensagem de feedback, indicando os usuários que agendaram atendimento pelo WhatsApp, 39% relataram não terem recebido a mensagem. Houve o relato de coordenadoras que não lembravam do recebimento da mensagem, alegando que são muitas as informações compartilhadas no WhatsApp e isso pode facilmente ter se perdido. Também houveram dificuldades com o número de telefone registrado.

Dentre as coordenações que receberam, ao serem questionadas se a mensagem de feedback foi o suficiente para que pudessem garantir atendimento dessas pessoas conforme o agendamento, 64% achou a mensagem suficiente e 36% achou parcialmente suficiente. Para que o atendimento fosse garantido, as coordenações relataram precisar do nome completo dos usuários, e não apenas o primeiro nome, como foi enviado.

A partir dessa mensagem de feedback, para garantia do atendimento das pessoas, as coordenadoras relataram que deixaram avisado na recepção os agendamentos, inseriram diretamente os usuários nas agendas do dia, conferiram se os usuários compareceram, diminuíram a disponibilidade de demandas espontâneas para aquele dia e reagendaram os usuários para outro dia, quando necessário. A frequência de respostas foi conforme este gráfico:

Conduta a partir da mensagem de feedback

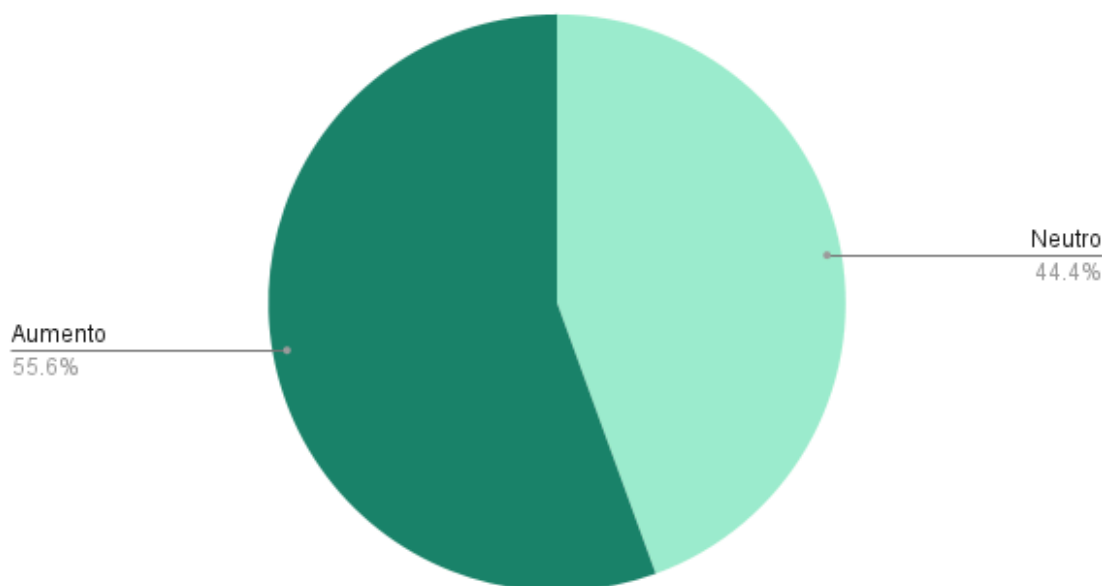


3.2.8 Impacto da iniciativa no serviço

Após o envio de mensagens, 55,6% das coordenadoras relataram que houve um aumento na procura dos serviços e 44,4% relataram que o efeito foi neutro. Não

houveram relatos de diminuição da demanda por atendimento de citopatológico ou condições crônicas.

Que efeito a iniciativa teve na procura de serviços?

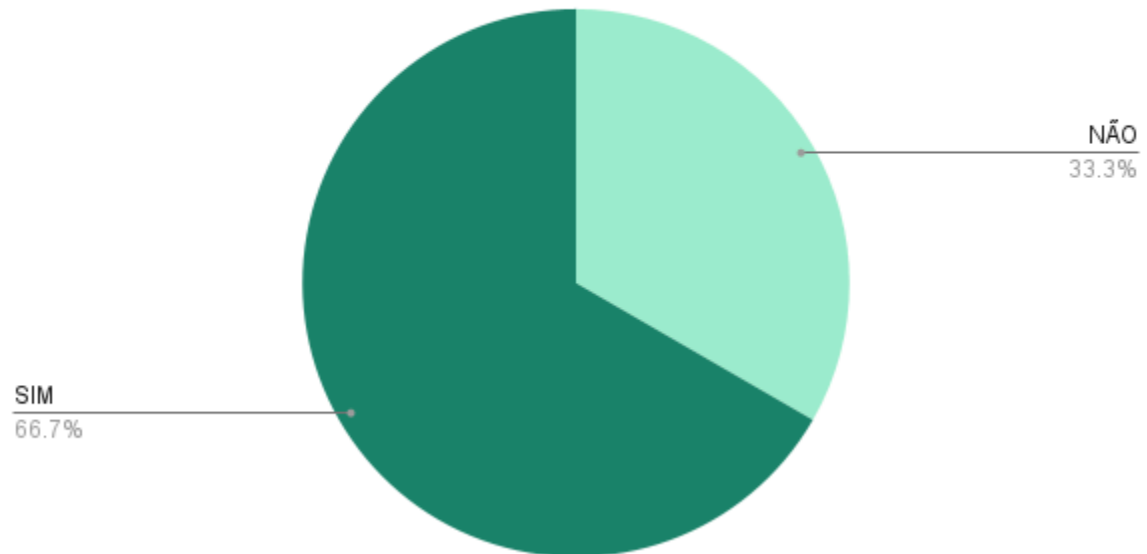


Dentre as coordenadoras que indicaram um aumento na procura do serviço de saúde, 90% relatou que foi possível atender a demanda gerada, algumas relatando que a adaptação foi tranquila e poderiam dar conta de ainda mais atendimentos decorrentes das mensagens. Apenas uma coordenadora indicou que em determinado dia não foi possível realizar todos os atendimentos, sendo necessário orientar a população a retornar em outro dia. Nota-se, também, que este aumento não foi constante entre as equipes de uma mesma unidade (como as mensagens engajarem mais no território de uma equipe do que de outra) e não foi constante entre os diferentes públicos testados (houve maior aumento de demanda para citopatológico do que para condições crônicas).

Em relação às pessoas que procuraram a unidade de saúde para atendimento após o recebimento de mensagens, 66,7% das coordenadoras notaram uma mudança no perfil do público que buscou atendimento. A iniciativa impactou pessoas que não acessavam a unidade há bastante tempo, e/ou não estavam sendo impactadas pelas buscas ativas dos Agentes Comunitários de Saúde. Embora houve relatos como esse

para os dois público-alvo que trabalhamos, recebemos mais relatos desse tipo referente à coleta de citopatológico.

A equipe percebeu diferença no público que recebeu atendimento?



3.3 Percepções da população que recebeu a mensagem enviada

Apesar de não ter ocorrido entrevistas com o cidadão pós-realização do projeto, foi possível na visita de campo, especialmente do município de Palmeira das Missões encontrar alguns usuários que foram impactados pelo programa. Houve uma diferença significativa das respostas entre o público alvo de citopatológico e de crônicos.

Em uma das primeiras visitas, se encontrou uma usuária que tinha recebido o tipo de mensagem A em que era possível agendamento em que a mesma agendou e procurou a unidade completando todo o ciclo do produto. A mesma ao ser perguntada sobre sua experiência com o produto relatou:

“Me ajudou que eu era desinteressada, aí eu percebi que precisava fazer [o exame]. Se pudesse me avisar sempre [por Whatsapp] eu gostaria.

(...) Eu achei muito prático, foi só chegar e mostrar o celular. Agora to com a saúde em dia sem precisar enfrentar fila.”.

Outras duas usuárias alegaram que não sabiam se tinham recebido a mensagem e ao pesquisar dentro do WhatsApp descobriram que sim. Uma não tinha percebido o conteúdo da mensagem pois outra pessoa tinha mexido no celular e a outra recebeu mas não deu atenção no momento. A usuária também disse que se sentiria feliz em receber as mensagens e que facilitaria a procura na unidade, mas tem medo de cair em algum golpe.

Uma usuária que inclusive era uma ACS estava com o número registrado como se tivesse clicado na opção “Não sou eu”. Ao ser questionada sobre isso verificou e descobriu que o número de sua ficha de cadastro na verdade pertencia ao seu marido e que seu marido que tinha clicado no botão de “não sou eu” e não a informado. A mesma não sabia disso, o que demonstra como os núcleos familiares não necessariamente funcionam para disseminação das informações de conscientização de saúde.

Todas as usuárias entrevistadas esse citopatológicos normalmente procuram a unidade presencialmente para poder agendar suas consultas e exames.

Outros relatos do impacto para o cidadão de citopatológico foram captados com coordenadores de equipe nos municípios de Juitituba:

“Porque o principal benefício é que impacta muito os pacientes, sabe? Eles sentem que alguém se importa em saber que não fez o exame ou que não tem procurado a unidade. Com as mensagens eu notei uma procura pelo exame. Tinha uma pessoa que fazia 13 anos que não fazia o papanicolau. Eu até printei a mensagem e mandei para quem não tinha recebido falando que elas iam receber e que tinham que fazer o exame.”

“O programa foi ótimo porque minha mãe recebeu mensagem para fazer o papanicolau, a secretária que trabalha aqui recebeu mensagem e fazia 5 anos que ela não fazia [o exame].”

Já para crônicos diferentemente, houve muitos relatos de ausência de recebimento de mensagens. A ausência de recebimento de mensagens foi decorrida de alguns fatores: algumas pessoas afirmaram que trocaram de número, o que fazem constantemente, e outras pessoas que pertenciam a familiares. Diferente do notado em citopatológico, os familiares que eram esposa e filha repassaram as mensagens aos mesmos e eles realizaram o atendimento.

Outro ponto é que todos os usuários alegam que já vão de seis meses até as unidades fazerem a renovação da receita, entretanto os mesmos não faziam a realização do exame mostrando que talvez a troca de comportamento mapeada estava errada e o problema não era a ida a unidade e sim a realização do exame. Uma das usuárias afirmou que media a pressão somente no aparelho de casa e só faz na unidade quando a pressão está extremamente alta e está passando mal. Outro usuário identificou que não usa o WhatsApp e prefere ligação.